PAUTA DE CHEQUEO
NORMA TÉCNICA 247: TRAZABILIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN PRESTADOR DE SALUD INSTITUCIONAL

ANTECEDENTES:

En Chile en el año 2013, el Ministerio de Salud mediante el Dpto. de Calidad y Seguridad de la Atención, elaboró un conjunto de normas técnicas, bajo el alero del art. 4 de la Ley 20.584, con el fin de otorgar una atención de salud segura. Dichas normas abarcan los ámbitos de procesos quirúrgicos, transfusiones sanguíneas, cuidados y dispositivos médicos. Respecto al uso seguro de los DM durante la atención de salud, se tiene la Norma Técnica de "Mantenimiento *preventivo de equipamiento médico crítico*", la norma de "*Sistema de Tecnovigilancia*" y la norma técnica que "*Establece la obligatoriedad de implementar un sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los dispositivos médicos al momento de su recepción por prestadores institucionales de salud*". Con el propósito de avanzar y complementar los datos solicitados en esta última, se publicó la NT sobre trazabilidad de dispositivos médicos.

OBJETIVO:

Estandarizar los requisitos de la Norma Técnica sobre seguridad y calidad de la atención respecto de la trazabilidad de dispositivos médicos en prestador de salud institucional con el propósito de contribuir a una efectiva implementación.

ALCANCE:

Los equipos médicos indicados en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de la Atención sobre mantenimiento preventivo de equipamiento médico crítico o, la norma que la reemplace[1]. Los DM considerados en el sistema de Acreditación de Prestadores Institucionales de Salud[2].

SIGLAS Y ABREVIATURAS

DM	Dispositivos Médicos
NT	Norma Técnica

[1] https://www.minsal.cl/seguridad-y-calidad-de-la-atencion-marco-legal/

[2] https://www.superdesalud.gob.cl/observatorio/674/w3-propertyvalue-7989.html

Pauta de chequeo:

Documentación de carácter Institucional					
Aplicación de la norma			SI	NO	NA
1	El director técnico de la institución designa formalmente, mediante un documento de carácter institucional, a un **profesional responsable** de resguardar el sistema de registro de la trazabilidad de DM.				
2	El documento formal que designa al responsable de la implementación de la NT establece horas para esta función				
3	El director técnico de la institución designa formalmente, mediante un documento de carácter institucional, a un **reemplazante** de resguardar el sistema de registro de la trazabilidad de DM.				
4	El prestador institucional de salud describe cómo se realizará la simulación de trazabilidad de los DM, según norma.				
De constatación					
5	El prestador Institucional cuenta con un **sistema de registro**, manual o electrónico que consigne datos sobre trazabilidad de DM.				
	5.1 Los registros mínimos considerados en el sistema local consideran:				
	5.1.1	Datos indicados en la NT N°226[3]o que la reemplace			
	5.1.2	Estado DM[4]			
	5.1.3	N° Registro sanitario[5], si corresponde, cuando sea exigido.			
	5.1.4	Forma de adquisición[6]			
	5.1.5	Fecha de la recepción conforme del DM[7]			
	5.1.6	N° de inventario[8], si corresponde			
	5.1.7 Datos relacionados al área o servicio clínico que utilizará el DM				
		5.1.7.1 Nombre del área o servicio clínico			
		5.1.7.2 Fecha de recepción del DM en el área o unidad clínica			
	5.1.8 Datos relacionados al paciente, según ficha clínica, en caso de los DM implantables señalados en la presente norma (no aplica este ítem para los DM no implantables)				
		5.1.8.1 RUN del paciente[9]			
		5.1.8.2 Fecha de implantación y explantación (si aplica) del DM			
		5.1.8.3 Nombre y apellido del profesional que realiza la implantación			
		5.1.8.4 Nombre de la prestación quirúrgica o procedimiento			

[3] Datos NT °226: Nombre del producto o dispositivo médico, con la denominación al interior del establecimiento de salud; identificación del proveedor; N° de guía/factura; modelo (cuando corresponda); N° de lote/serie y; fecha de vencimiento

[4] Devuelto al proveedor, en bodega del establecimiento, implantado, traspaso a otro establecimiento, destruido y/o eliminado, en cuarentena, en comodato, arriendo, compra particular, rechazo de uso, retirado, reemplazado o explantado, en uso, entre otros.

[5] Otorgado por el Instituto de Salud Pública (ISP)

[6] Por trato directo, por Ley de compras, por licitación pública, por donación, por CENABAST, entre otros

[7] Cuando el establecimiento validó el DM entregado por el proveedor u otro, según lo solicitado, antes de ser utilizado o implantado en el paciente

[8] Corresponde un número contable que asigna el establecimiento para identificar el activo fijo no financiero. Este número es único, no se repite. Su configuración no es estándar, por lo que cada establecimiento define el tipo de número de inventario

[9] En caso de que el paciente no cuente con RUN se debe contar con el N° de pasaporte, o algún registro único que identifique al usuario.

6	El prestador institucional de salud ha realizado la simulación de trazabilidad de los DM, al menos una vez al año, según lo descrito en protocolo local.			